Dr. Murali's
HOPEHOSPITAL
Assured | Committed | Proficient

Plot No. 2, Teka Naka,
Beside Go-gas, Kamptl Road,
Nagpur-440017
Contact : 9823555053 / 9373111709
Website : www.hopehospital.com
Email : cmd@hopehospital.com

एनेस्थीसिया के लिए सुचित सहमती

मरीज पहचान विवरण :

[illegible] ध्य हो तो यहाँ चिपकाए Narendra Waghale UHID :UHHO25F23007 Visit ID: IH25F23011 Age/Gender: 49 Year / Male Consultant: Dr.Ritesh Navkhare(Neurosurgeon) Tariff: PMJAY	यु एच आई डी नंबर / आय पी नंबर नाम : mr. Narendra waghale उम्र : 49 years लिंग : male

की जानेवाली प्रक्रिया lumber laminectomy c fixation

मै पुष्टि करता हुं की मैने मरीज को प्रस्तावित एनेस्थेटिस्ट (जनरल/राजनल/सेडेशन) के प्रकार के बारें में स्पष्ट कर दिया है तो की मेरे मत से मरीज तथ/या मरीजों के अभिभावकों में उक की समझ के अनुरुप है।

हस्ताक्षर.....Pkamuker..... तारीख ..26.../...06.../...25.....

अनेस्थेटिक / कंसलटेंट का नाम : .....Dr. Prasad Gunakar.....

मरीज /माता-पिता / अभिभावक :

कृपया इस फार्म तथा दुसरी तरफ दिए गये नोटिस को ध्यानपुर्वक पडे, अगर कोई स्पष्टीकरण आपको समझ न आए या आप और अधिक जानकारी चाहते हो तो डॉक्टर से पुछताछ करें।

कृपया जांच करने की फॉर्म में दी गई सभी जानकारीयां सही है। अगर ऐसा है और आपने स्पष्टीकरण को समझ लिया है तभी फॉर्म पर हस्ताक्षर करें।

* जनरल एनेस्थसिया लेनेवाले मरीजो की श्वास नली में एक ट्यब (एंडोट्रेकियल इंटयुबेशन) डाली जाएगी इस टयुब में डालने से गले मे खराश हो सकती है या आवाज भारी हो सकती है। इसके अलावा दांत या मसूडे भी ढीले हो सकते है। यदि इन्हे श्वास देने के लिये वेंटीलेटर पर रखा जा सकता। बहुत ही कम, मगर संभावना आवश रहती है।

* यह शल्यचिकित्सा आपके आपके सर्जन और संबंधित एनेस्थेटिस्ट के निर्णय के अनुसार जनरल एनेस्थीया/ स्पाइनल /एपीडयुरल लोकल एनेस्थसिया के अंतर्गत किया जा सकता है।

* साथ ही किसी तरह की एलर्जिक प्रतिक्रिया भी हो सकती है। यदि आपको कोई एलर्जी हो तो सुचित करे,यदि आपका पिछली शल्यचिकित्सा या एनेस्थसिया के दौरान कोई समस्या हुई हो तो अपने डॉक्टर को अवश्य बताये, मरिज / अभिभावक का नाम (जो आवश्यक न हो उसे काट दे)

जानता हुं * कि जो प्रस्तावित है उसके बारे में इस फॉर्म में अंकित नाम के डॉक्टर ने मुझे समझा दिया है।

जानता हुं * कि प्रक्रिया उस डॉक्टर द्वारा नाकि जो मेरा उपचार कर रहे है।

* कि इस फॉर्म में वर्णित जांच-परीक्षा या उपचार के अतिरिक्त कोई अन्य प्रक्रिया तभी की जाएंगी, अगर वो आवश्यक हो तथा मेरे हित मे हो एवं चिकित्सा कारणो से उपयुक्त ठहराई जा सकती है।

सहमत हुं * कि मुझे जिस प्रकार के एनेस्थेटिक के बारें में बताया गया है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है।

१) नाम : मीना वघाले मरीज से संबंध : पत्नी हस्ताक्षर : Meena २) नाम : मरीज से संबंध : हस्ताक्षर :	मरिज के हस्ताक्षर : नरेन्द्र वघाले या/और : मनोनीत हस्ताक्षरी : (विविध अभिभावक या मरीज के द्वारा प्रधिकृत) नाम : मरीज से संबध : तारीख व समय :

पुनश्च : आप सुचित सहमति पर हस्ताक्षर करने से पहले उपयुक्त कारवाही सुरू करने से पहले उस मुद्दे पर डॉक्टर से बिना किसी संकोच चर्चा कर सकते है।

Dr. Murali's
HOPEHOSPITAL
Assured | Committed | Proficient

Plot No. 2, Teka Naka, Beside Go-ga
Kampti Road, Nagpur-440017
Contact : 9823555053 / 9373111709
Webside : w.w.w.hopehospital.com
Email : cmd@hopehospital.com

INFORMED CONSENT FOR ANAESTHESIA

PATIENTS IDENTIFICATION DETAILS :

Please place ID stickers here if available	UHID No./IP No : Name : Age : Sex :

PROCEDURE TO BE PERFORMED :

Confirm that I have explained the type of Anesthetic (General/Regional/Sedation) proposed to the patient in terms which in judgment are to the understanding of the patient and/ or one the parents or guardians of the patient

Signature ..... Date : ...../...../.....
Name of the anesthetist/ Sonsultant .....
PATIENT / PARENT / GUARDIAN

Please read this from and the notes overleaf very carefully.

If there is anything that you don't understand the explanation, or if you want more information you should ask the doctor.

Pleases check that all the information on the form is correct and understand the explanation, the sign the form

Patient reseiving general anesthesia may require tube in the windpipe (Endracheal Intubations) the intubation could cause a sore throat and hoarseness. also teeth or dental prosthesis could become loose, if they develop respiratory complications they may be put on ventilators to support their lungs. Accident death is extremely rare, however a very remote possibility of this always exists in any surgery or anesthesia.

The operation may be performed under general anesthesia/epidural local anesthesia per the decision of the surgeon and the anaesthetist concerned.

Alklergic reaction to occur. You need to inform us of allergy you have. If you have any problems in previous surgery anaesthesia. The same should be communicated to the doctor

Name of the Patient / Guardian (delete as necessary.)

I agree to what is proposed which has been explained to me by the doctor named on this form.

I understand that the procedure may not be done by the doctor who has assessed me.

That any procedure is addition to the investigation or treatment described on this from will only be carried out if it is necessary and in my best interest and can be justified for medical reasons.

I agree To the use of the type of anesthetic that I have been told about.

1) Name :..... Related to patient :..... Signature :..... 2) Name :..... Related to patient :..... Signature :.....	Patient's Signature :..... Or/and Designated Signatory :..... (legal guardian or as authorized by the patient) Name :..... Relationship :..... Date & Time :.....

PS : You are wecome to discuss any of the points mentioned above with the doctors attending on you before signing on the informed consent.

Dr. Murali's
HOPE HOSPITAL

Anaesthesia Monitoring Form

Name Narendra Waghale
Age 49 yrs Sex Male IP No
AMC
Allergies

Narendra Waghale
UHID :UHHO25F23007
Visit ID: IH25F23011
Age/Gender: 49 Year / Male
Consultant: Dr.Ritesh Navkhare(Neurosurgeon)
Tariff: PMJAY

Diagnosis Lumbar P.I.V.D. c Radiculopathy.
Proposed operation Lumbar laminectomy c foraminotomy UGA

Height.....
BMI.....

Past Medical History: K/C/O:- H.T.N. On medication :- Tab Amlo-5mg

Anaesthetic History Not significant.
Exercise Tolerance 2 flos

HEMATOLOGY
Hb/Hct 14.1
TC 6,400 (P) (L) (M) (E)
DC 71/24/03/02
Platelets 2.25 lacs
BT/CT
PT/INR 1.06.
APTTK

CVS : S1 S2 ⊕.
ECG NSR, WNL.
Echo
TEE
Holter

R/S B/L. AEC
PFT
CXR WNL.

Smokar Y/N
Alcohol Y/N

Diabetis
NIL NIDDM IDDM
F/PP/RBS
Subject to

HBSAg. Non-Reactive
HIV.
HCV.
Blood Group.....

Nervous System Conscious oriented

	Rt	U.L	L.L.	
Carotids		5	5	5	5
CT Scan	Lt.	5	5	5	5

Sensory intact.

Renal
Blood Urea 32.5.
Creatinine 1.06.

GI SYSTEM
Jaundice Y/N APD Y/N
S. Bill 0.77 D 0.19. I 0.58.
ALK Phos 92.8
Urinalysis
Albumin 3.98 Globulin 3.36
NA/K/Ca/Mg 140/3.87/1.09
GI Bleed
SGOT/PT 23.2/29.5.
Other

AIRWAY ASSESSMENT MPG II
Mouth Opening Adequate (3 fingers).
Teeth NO LT, MT
Neck Movements ⊕
Spine

Pulse 88/min.
BP 144/92 mm of hg.
Allen's test
Past History :- Not significant.

Types Of Anaesthesia:
Monitored Anaesthesia care | Sedation Anaesthesi | General Anaesthesia | Regional Anaesthesi

ASA Status 1 2 3 4 5 E
Risk Explained Y/N

Current Medication

Preopretive instructions

NPO from 8 hrs.

Assessed by Dr. Pramod Chavan.
Date 26/6/2025.

Dr. Murali's HOPE HOSPITAL PVT. LTD. Hope Hospital NMC Reg.No.-983

OPERATIVE RECORD

EVENTS															
OBSERVATIONS	7:30	7:35	7:40	7:45	7:50	7:55	8:00	8:15	8:30	8:45	9:00	9:15	9:30	10:00	
HR	80	86	78	74	86	82	90	98	94	82	86	90	88	84.	
ECG															
BP S	144	142	134	130	124	118	110	104	108	112	118	110	116	124	132
D	90	88	80	78	80	74	72	76	70	76	82	70	74	86	88
M															
CVP															
PA S															
D															
M															
PCWP															
TEMP T1															
ACT															
CO/CI															
SVE/I															
PVR/I															
SPO 2	← 99% → 100% →														
ETCO 2															
RR	14	14	14	14	14	14	14	14	15	14	14	15	14	14	
URINE															
K +															
PH															
PO 2															
~~PCO 2~~															
BE/HC3															
RBS															

INFUSIONS

IV Atracurium 10mg @ 8:50 Am.

DRUGS

Blood loss = 100-150ml.

O2/N20/AR: M/O O_2 + N_2O + Iph. Isoflurane on closed circuit on controlled ventilation.

A AGENT

FLUIDS

1	I @ NS.	IV Ondem 4mg.
2		IV. Tramexa 1gm.
3	II @ RL.	IV. Monocef 2gm.
4		

pt. taken on Table.
Multipara monitors attached
IV line secured.

P/O c̄ 100% O2 by face mask on spontaneous ventilation for 3 mins on closed circuit.

P/M c̄ IV Glyco 0.2 mg
S/D c̄ IV midaz 1 mg + IV pentazyl 30 mg

I/D c̄ IV propofol 100 mg + IV Scolone 100 mg

I/T c̄ PLETT No. 8.0 cuffed DL scopy guided Blade line passed Beyond vocal cords. Cuff inflated B/L AEC, Tube fixed at 22 cm.
M/O O2 + N2O + Inh. sevoflurane on closed circuit on controlled ventilation.
IV Atracurium 50 mg given as skeletal muscle relaxant.
Pt. turned in prone position.

Reversal Notes:-
pt. turned to supine position.
pt. reversed c̄ IV neostigmine (neostigmine 2.5 mg + glycopyrolate 0.5 mg)
pt. Extubated after thorough OPS & POR.

P.T.O.

OT TIMES

Date: 26/6/2025	Arrival OT
Anaesth Start 7:30 Am	Incision
Operation end	Anaesth end

Operation performed: Lumbar spine fixation c̄ laminectomy G.A.

Anaesthetists: Dr. Pranali	Surgeons: Dr. Ritesh
Nurses	Perfusionist: Deepakhale

AIRWAY Management

Mask	ETT	LMA	Traecheostomy
Size 8.0 · Type	Cuffed		
Laryngoscope view			
Grade	I	II	III IV
Difficult, why			

ANAESTHETIC TYPE

GA/Sedation/Reginal	IV midaz 1 mg + IV pentazyl 30 mg +
GA	IV propofol 100 mg +
Induction	IV Glyco 0.2 mg + IV Scolone 100 mg
Maintainence	IV Atracurium 50 mg skeletal muscle relaxant.

REGIONAL

Soinal	Epidermal	Infiltration	ner
Brachial Plexus			
IV Regional			
Lever		Needle	
Catheter		Skin mark	
Position		Drug	

MONITOR

✓ ECG	✓ SPO2	ETCO2	temp
✓ NIBP	Art Line		CVP
PA catheter	AGM		Paw

SPECIAL TECHNIQUES

FOB	Awake Incubation	
DLT	TOE	CPB

POSTURE EYES EAR PLUGS

Post-operative vitals.

Events	
1-	Conscious oriented.
2-	P:- 84/min.
3-	B.P:- 124/80 mmHg.
4-	SpO2:- 99% (on R.A.).
5-	CVS:- S1 S2 +
6-	RS:- BIL AEC
7-	Advice:-
8-	
9-	- NBM for 6 hrs.
10-	- watch for vitals/neuro complications

CPB	ON	Clamp	ON
	OFF		Off
Time			

Heparin.....mg .....hrs .....m

.....mg.....hrs.....mg

PROTAMINE.....mg AT.....hrs

	Prebypass	Onbypass
URINE		
Anthrop. Fluid		
Blood Product		
Balance		

CPB MANAGEMENT

Additives	- I.V.F @ 100ml/hr NS/RL/DNS.
Cardioplegia	
Temp	- SOS O2 support.
Return of Activity	- ICU & Intensivist monitoring
Durg	
Pacemaker	- post-operative all Routine SOS collection
Weaning	
	- Inform SOS.

POST CPB

Dr. Pramod

DR. M. DE HOSPITAL PVT. LTD. Hope Hospital NABH Reg.No.663

TEE

	Per Operative	Post Operative
Aorta		
RWMA		
EF		
Valves		
Others		

TRANSFER NOTES

HR -	MV/rate -
ABP -	PIP -
PA/CVP -	SpO2 -
Temp -	ETCO2 -

Dr. Murali's
HOPEHOSPITAL
Assured | Committed | Proficient

Plot No. 2, Teka Naka, Beside Go-gas,
Kampti Road, Nagpur-440017
Contact : 9823555053 / 9373111709
Webside : w.w.w.hopehospital.com
Email : cmd@hopehospital.com

IMMEDIATE PREOPERATIVE RE-EVALUATION BY ANESTHETIST

Date : 26/6/25

Name of Patient Mr. Navendra wagale

Age 49 years

Sex male

Anesthetist Name Dr. Prasanali Gunkeer

Provisional Diagnosis Lumbar PIVD c̄ Radiculopathy

Name of Surgery Lumbar laminectomy c̄ fixation

Operative sits Right / Left

AIRWAY ASSESSMENT

ASA STATUS :

Anesthesia Plan :

MCA SEDN GA RA

Risk explained if any :

Anesthetist Name : Dr. Pranali.

Signature : Pranali

Date / Time : 26/6/25 6:30 AM

Patient / Relatives मीना वघाले

Relation पत्नी

Signature meena

Dr. Murali's
HOPEHOSPITAL
Assured | Committed | Proficient

Plot No. 2, Teka Naka, Beside Go-gas,
Kampti Road, Nagpur-440017
Contact : 9823555053 / 9373111709
Webside : w.w.w.hopehospital.com
Email : cmd@hopehospital.com

IMMEDIATE PREOPERATIVE RE-EVALUATION BY SURGEON

Name of Patient : Mr. Narendra waghale

Age : 49 years

Sex : male

Surgeons Name : Dr. Ritesh Navkhare

Provisional Diagnosis : Lumber PIVD c̄ Radiculopathy

Operative sits Right / Left :

Patient present vascular and neurological status of limbs :

Risk Explained if any :

Surgeons Name : Dr. Ritesh Navkhare

Signature :

Dr. M. HOPE HOSPITAL PVT. LTD.
Hope Hospital
NMC Reg.No.953

Patient / Relatives मीना वघाले

Relation पत्नी

Signature Meena